TÓM TẮT LÝ THUYẾT · MẮT

BÀI 1 Đỏ mắt: tiếp cận chẩn đoán và điều trị

Tóm tắt từ bài giảng 1. Red Eye - Diagnosis & Treatment.pdf (14 trang) · Giữ ý chính và dấu hiệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. ĐẠI CƯƠNG
2. SƠ ĐỒ TIẾP CẬN ĐỎ MẮT
3. VIÊM KẾT MẠC
4. XUẤT HUYẾT DƯỚI KẾT MẠC
5. CÁC NGUYÊN NHÂN ĐỎ MẮT CÓ ĐAU
6. BỆNH LÝ PHẦN PHỤ KHÁC

1. ĐẠI CƯƠNG

- Đỏ mắt là **một trong những triệu chứng nhãn khoa thường gặp**.
- Nguyên nhân đa dạng: từ bệnh **lành tính, tự giới hạn** đến tình trạng **cấp cứu đe dọa thị lực**.
- Mục tiêu: nhận diện **dấu hiệu cảnh báo** để xử trí ban đầu và **chuyển tuyến kịp thời**.

2. SƠ ĐỒ TIẾP CẬN ĐỎ MẮT

- Phân theo: **cấp hay mạn** → **một mắt hay hai mắt** → **có đau hay không đau**.

Nhóm	Không đau	Đau
Mạn, 2 mắt	Co rút mi, lồi mắt, song thị: **bệnh mắt nội tiết** (Basedow)	Mỏi mắt, nóng rát, ngứa: **khô mắt** (viêm kết giác mạc khô)
Mạn, 1 mắt	**Hở mi** (khép mi không kín): chuyển khám chuyên khoa **khẩn**	**Bất thường vị trí mi**: quặm, lật mi, lông xiêu
Cấp, 2 mắt	Phù kết mạc, theo mùa, tiếp xúc dị nguyên: **viêm kết mạc dị ứng**	Sau hàn điện: **viêm giác mạc do tia**; hoặc tiết dịch trong, sợ sáng, co quắp mi: **viêm kết mạc virus** – chuyển chuyên khoa
Cấp, 1 mắt	Mắt đập theo mạch: **dò động mạch cảnh – xoang hang** (chuyển khẩn); hoặc chảy máu lan tỏa đột ngột: **xuất huyết dưới kết mạc**	Nghi **dị vật, thủng nhãn cầu** hoặc **cơn glôcôm góc đóng cấp** (nhãn cầu **cứng như đá**): **cấp cứu**

3. VIÊM KẾT MẠC

- **Dị ứng:** ngứa, chảy nước mắt, **phù kết mạc 2 mắt**. Điều trị: **ngưng tiếp xúc dị nguyên**, **kháng histamine** tại chỗ và toàn thân; dự phòng bằng **thuốc ổn định dưỡng bào** hoặc kháng thụ thể H1.
- **Khô mắt:** cộm, khô rát, đỏ nhẹ; điều trị **nước mắt nhân tạo, gel bôi trơn** để tránh **viêm giác mạc sợi**.
- **Yếu tố cơ học:** bất thường mi (**lật mi, hở mi**), cọ xát liên tục gây tổn thương biểu mô → **phẫu thuật chỉnh hình mi**.
- **Vi khuẩn** (Staphylococci, Streptococci): đỏ mắt, **dính mi khi ngủ dậy**, **không đau, không nhìn mờ**, tiết dịch **mủ nhầy**, **vảy vàng** quanh mi. Nếu đau, sợ sáng, co quắp mi → nghĩ **ảnh hưởng giác mạc**. Điều trị: kháng sinh nhỏ nhóm **fluoroquinolones**.
- **Virus** (chủ yếu **Adenovirus**, lây thành **dịch**): khởi phát **1 mắt rồi lan sang mắt kia**; tiết dịch **nhầy trong**, ngứa, cộm xốn, **hạch trước tai**; **tự giới hạn khoảng 2 tuần**. Tránh tiếp xúc, **rửa tay** sạch; nước mắt nhân tạo giảm triệu chứng.

4. XUẤT HUYẾT DƯỚI KẾT MẠC

- Cơ chế: **thành mạch mỏng, dễ vỡ**.

- Xuất hiện **đột ngột, không đau, không ảnh hưởng thị lực**; thường sau **ho, hắt hơi mạnh, rặn (Valsalva)**.
- Liên quan: **tăng huyết áp, rối loạn đông máu, thuốc chống đông**.
- Xử trí: **đo huyết áp ngay** để loại trừ cơn tăng huyết áp cấp cứu; thường **tự hấp thu trong 2–4 tuần**; tư vấn khám tim mạch.

5. CÁC NGUYÊN NHÂN ĐỎ MẮT CÓ ĐAU

- **Viêm loét giác mạc – CẤP CỨU NHÃN KHOA:**
  - Cơ năng: cộm xốn, **cảm giác dị vật**, **đau lan hốc mắt**, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, **nhìn mờ**.
  - Thực thể: mi co quắp, sưng nề; **cương tụ rìa**; tổn thương giác mạc; có thể có **mủ tiền phòng**.
- **Viêm củng mạc:** thường ở **phụ nữ 40–60 tuổi, có bệnh toàn thân**; **50% bị 2 mắt**.
  - Thể **lan tỏa ~40%** (nhẹ nhất), **dạng hạt ~45%**, **hoại tử** hiếm nhưng **đau +++**, có thể **mỏng củng mạc, thủng nhãn cầu**.
  - Đau nhức, nhìn mờ, chảy nước mắt, sợ sáng; cương tụ kết mạc khu trú hoặc lan tỏa.
- **Viêm mống mắt – thể mi:** đau, đỏ, **sợ ánh sáng**; **cương tụ rìa**; **tủa mặt sau giác mạc**, fibrin; **nhãn áp thường thấp** (có thể bình thường hoặc tăng); **phản ứng thể mi (+)**.
- **Glôcôm góc đóng cấp – CẤP CỨU NHÃN KHOA:**
  - Cơ năng: đau, đỏ, nhìn mờ; **thấy quầng nhiều màu sắc**; **buồn nôn, nôn ói**.
  - Thực thể: cương tụ rìa; giảm thị lực, **nhãn áp tăng cao**; **tiền phòng nông**; **đồng tử giãn méo, phản xạ ánh sáng (–)**.

6. BỆNH LÝ PHẦN PHỤ KHÁC

- **Chắp, lẹo:** viêm nhiễm vi khuẩn cấp tại **tuyến bã nhờn / mồ hôi bờ mi**; nốt sưng đỏ, đau khu trú; điều trị **chườm ấm + thuốc mỡ kháng sinh**.
- **Quặm mi (entropion):** bờ mi lộn vào trong → lông quặm cọ giác mạc. **Lật mi (ectropion):** bờ mi lộn ra ngoài → hở mi, khô rát, chảy nước mắt. Cần **phẫu thuật chỉnh hình**.
- **Dò động mạch cảnh – xoang hang:** mắt đỏ, **mạch máu kết mạc giãn ngoằn ngoèo**, **lồi mắt đập theo nhịp mạch**, **tiếng thổi trong hốc mắt** → chuyển viện **chụp MRI mạch máu khẩn cấp**.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế bài giảng gốc. Đối chiếu 1. Red Eye - Diagnosis & Treatment.pdf khi cần chi tiết.